

日本の移植医療がすくない理由 ～私たちにできること～

健康・栄養・福祉講座

2301浅野真由

➤ はじめに

日本で小さい子供の臓器提供があれば大きなニュースになる。難病を抱える小さい子供が臓器移植を受けるためにアメリカにわたるとニュースになる。そのニュースを見るたびに、日本国内での臓器移植は少ないという事がわかる。アメリカでは臓器移植のたびにニュースになったりしない。そこでひとつの疑問が生まれた。アメリカと日本での移植医療の差が生まれているのにはどのような理由があるのか、ということである。

➤ 問題提起

日本の臓器移植が少ないのにはどのような理由があるのか。

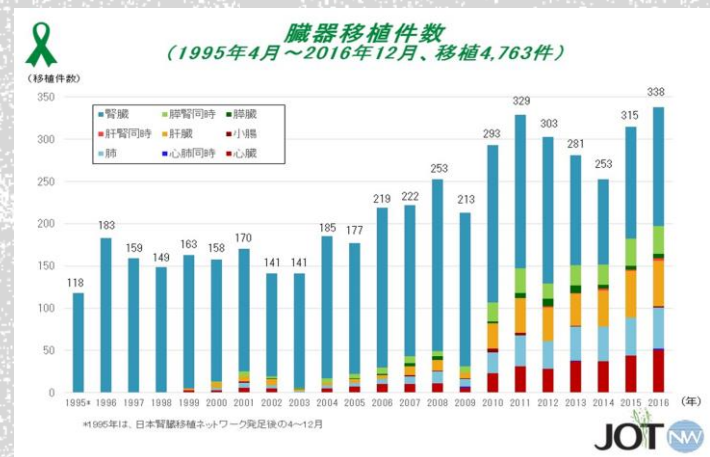
➤ 意見

日本の移植医療のシステムが整っていないことと、移植医療についての知識が少ないからである。

➤ 論証

(1) 移植医療に大きくかかわる『脳死判定』

臓器を提供する人(ドナー)は、わかりやすく言うと体内の臓器は健康であるが、脳内の機能が停止している状態である。この状態を脳死であるという。脳死と判断するにはさまざまなテストをする必要がある。しかし、ここでの問題は『心臓は動いている』ということ。患者の家族は、“心臓が動いている＝生きている”と考える。だが、医者は“脳の機能が停止している＝回復の見込みがない”と判断する。



(2) ドナーコーディネーター不足

ドナーコーディネーター不足も日本の移植医療が進まない原因といえる。アメリカや韓国では、専門職としてドナーコーディネーターが存在する。現在ドナーコーディネーターは日本では現在、日本移植ネットワークに所属する臓器移植コーディネーター約20名及び日本臓器移植ネットワークより委嘱を受けた都道府県コーディネーター約50名が活動している。多くは看護師や臨床検査技師などの国家資格を持つ。岡山県では三人だが、うち一人が活動休止中で実質二人。骨髄採取件数が少ない香川などを除き岡山、広島など二十四都道府県で不足としている。



➤ 結論・今後の課題

論証で述べたように、脳死判定の際の医者側と遺族側の認識の違いが移植という選択に至らなくなる理由と考えられる。また、移植に大きく関わるドナーコーディネーターの不足。この二つが改善されることで日本の移植医療はもっとスムーズにすすむと考える。

人の臓器を提供してもらって生きることに対して反対する声もある。一人一人に考え方は様々である。移植でしか治療できない人や移植を待ち望んでいる人、そして、死後に臓器を提供してもいいという人の意思も移植を望まない人の意思も、移植を望む人の意思もそれぞれの意見を尊重できる社会であるべきだと思う。

謝辞・参考文献など

<https://www.jotnw.or.jp/d-coordinator/index2.html> 日本臓器移植ネットワーク

<http://diamond.jp/articles/-/62001?page=4>

<http://medica.sanyonews.jp/article/645/> 岡山の健康医療ガイド